DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

IDENTIFICACIÓN

Paciente: DUVALIER HERNANDEZ CARDONA **Identificación** CC 1113793101
Edad: 27 AÑOS **Empresa:** NUEVA EPS S.A CONTRIBUTIVO-2025
Sala: QUIROFANO 3 **Fecha programación de cirugía:** 05/11/2026

Sede de Atención: SEDE PRINCIPAL

CIRUGÍAS

CANT	CÓDIGO	NOMBRE DE LA CIRUGÍA	Grupo Quirúrgico	UVR
1	**512104**	**COLECISTECTOMIA VIA LAPAROSCOPICA**	Y41	

Cirujano: CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

1	**540015**	**DRENAJE DE COLECCION INTRAPERITONEAL VIA LAPAROSCOPICA**	Y39	

Cirujano: CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

1	**541702**	**LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA LAPAROSCOPICA**	Y38	

Cirujano: CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

1	**545101**	**LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA LAPAROSCOPICA**	Y40	

Cirujano: CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad:** CIRUGIA GENERAL
Vía:

DESCRIPCIÓN CIRUGÍA

CIRUJANO ES183 CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ **Especialidad** CIRUGIA GENERAL

512104 **COLECISTECTOMIA VIA LAPAROSCOPICA**
540015 **DRENAJE DE COLECCION INTRAPERITONEAL VIA LAPAROSCOPICA**
541702 **LAVADO PERITONEAL TERAPEUTICO VIA LAPAROSCOPICA**
545101 **LISIS DE ADHERENCIAS PERITONEALES VIA LAPAROSCOPICA**

Dx Preoperatorio: K800 CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA

Dx Postoperatorio: K800 CALCULO DE LA VESICULA BILIAR CON COLECISTITIS AGUDA

Tipo de Herida: LIMPIA CONTAMINADA **Tipo de Anestesia:** GENERAL **Tipo de Cirugía:** URGENCIAS
Cantidad de Sangrado: 0 **ml.** **Vía:** UNICA VIA
Clasificación de riesgo quirúrgico : **A.S.A :** 0 **NNIS :** 0
Realización Acto Quirúrgico: **Fecha Inicio** 05/11/26 **Fecha Final** 05/11/26
Hora Inicio 17:00:00 **Hora Final** 18:00:00
Tiempo de Perfusión: 0 **Minutos** **Tiempo de Clamp:** 0 **Minutos**

Descripcion Quirúrgica:

BAJO ANESTESIA GENERAL, PREVIA SEPSIA Y ANTISPESIA,
SE COLOCACN CAMPOS ESTERILES, SE REALIZA INCISION TRASNUMBILICAL BAJO TECNICA HASON SE PASA PRIMER PURETO DE 10 MM
SE PASA SEGUNDO PEURTO BAJO VISION DIRECTA FLANCO DERECHO DE 5 MM
SE PASA TERCER PUERTO BAJO VISION DIRECTA SUBXIFOIDEO DE 10 MM
SE EVIDENCIA:
VESICULA BILIARDE PAREDES ENGROSADAS DE GRAN TAMAÑO CON MULTIPLES CALCULOS.
ADHRNCIAS COLECISTODUODENAL FIRMES
VESIUCAL DE COLESTASIS CON GRAN CONTENIDO DE BILISY LIQUIDO INFLAMATORIO PERIVESIUCALR 300 ML APROX
CISTICO DE CARCATERISTICAS NORMALES
VIA BIALIR PRINCIPAL DE CALIBRE NORMAL
ARTERIA CISTICA ANTERIOR
LECHO VESIUCALR CRUENTO

SE PROCEDE ACON DISECCION DE ADHRENCIAS A HIGADO YCOLECISTODUODENALES,
SE REALIZA DISECCION ROMA Y CON HIDRODISECCION HASTA INDIVIDUALIZAR VESIUCAL
SE PROCEDE A EVACUAR CONTENIDO VESIUCALR PARA MEJORAR SU MANIPULACION 300 ML APROX.
Y SE DREAN CONTENIDO INFLAMATORIO PÉRIDIVERTICULAR 300 ML APROX
SE IDENTIFICACION DE TRINGULO DE CALOT, SE TIENE VISION DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN DE CIRUGÍAS

SE REALIZA PINZAMEINTO CON CLIPS DE 300 SOBRE ARTERIA CISTICALA SE CLIPA CON 2 CLIPS
SE REALIZA PÍNZAMEINTO CON CLIPS 300 SOBRE CONDUCTO CISTICO SE REALIZA CLIPADO CON 4 CLIPS,
SE REALIZA COLECISTECTOMIA CISTOFUNDICA
LECHO VESIUCLAR CRUENTO Y DE SANGRADO FACIL
SE REALIZA HEMOSTASIA DE LECHO VESIUCALR
SE PROCEDE A LAVADO DE CAVIDAD ABDOMNINAL CON 1500 ML DE LIQUIDOS
Y SE EXTRAEN CUAGULOS
SE RETIRA VESIUCAL
SE REALIZA CAUTERIZACION DE LECHO VESICULAR.
SE TIENE CONTEO DE MATERIAL COMPLETO
SE RETIRAN PUERTOS Y NEUROMPERITONEO
SINTESIS D EPUERTOS CON VYCRIL 1
PIEL Y TCS CONPROLENE 3.0
FIN DE ACTO QUIURURGICO

Complicaciones : **SI** ☐ **NO** ☒

Hallazgos :

VESICULA BILIARDE PAREDES ENGROSADAS DE GRAN TAMAÑO CON MULTIPLES CALCULOS.
ADHRNCIAS COLECISTODUODENAL FIRMES
VESIUCAL DE COLESTASIS CON GRAN CONTENIDO DE BILISY LIQUIDO INFLAMATORIO PERIVESIUCALR 300 ML APROX
CISTICO DE CARCATERISTICAS NORMALES
VIA BIALIR PRINCIPAL DE CALIBRE NORMAL
ARTERIA CISTICA ANTERIOR
LECHO VESIUCALR CRUENTO

Tejidos enviados a patología : **SI** ☒ **NO** ☐

VESICULA BILIAR

Carlos I Forero

CARLOS IVAN FORERO RAMIREZ
Reg. 760629
CIRUGIA GENERAL

*** * * FIN DEL REPORTE * * ***